

Epilepsi pada Anak: Petunjuk Praktis Sehari-hari

Hardiono D. Pusponegoro



 **anaku.id**

**BADAN PENERBIT
IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA**

**Epilepsi pada Anak:
Petunjuk Praktis Sehari-Hari
Jangan takut, banyak yang bisa kita lakukan**

Penulis: Hardiono D. Pusponegoro



**BADAN PENERBIT
IKATAN DOKTER ANAK INDONESIA**



**Epilepsi pada Anak:
Petunjuk Praktis Sehari-Hari
Jangan takut, banyak yang bisa kita lakukan**

Penulis: Hardiono D. Pusponegoro

Epilepsi Anak:
Petunjuk Praktis Sehari-Hari
Jangan takut, banyak yang bisa kita lakukan

Penulis: **Hardiono D. Pusponegoro**

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin Penyunting dan Penerbit.

Cetakan Pertama 2025

Diterbitkan oleh:
Badan Penerbit Ikatan Dokter Anak Indonesia
Gedung IDAI
Jl. Salemba I No. 5
Jakarta Pusat 10430
Telp. / Fax: (021) 3912577
E-mail: badanpenerbit@idai.or.id

BARCODE ISBN

Kata Pengantar

Epilepsi merupakan salah satu gangguan neurologis tersering pada anak. Diperkirakan, sekitar 3-10 dari setiap 1.000 anak mengalami epilepsi aktif, dengan insiden tertinggi terjadi pada tahun pertama kehidupan. Di negara berkembang, angka kejadian mungkin lebih tinggi karena keterbatasan deteksi dan pengobatan.

Peran sejawat di lini pertama penanganan epilepsi sangat penting dalam proses diagnosis, karena sebagian besar pasien anak dengan epilepsi pertama kali akan datang ke praktik dokter umum atau dokter spesialis anak. Beberapa jenis epilepsi, seperti, bangkitan tonik-klonik umum, absence, bangkitan parsial kompleks, dan Benign Rolandic Epilepsy, mencakup lebih dari 80% kasus epilepsi anak yang dapat dikenali oleh sejawat.

Memilih obat anti epilepsi (OAE) yang tepat dapat dipermudah dengan menggunakan OAE lini pertama. Sekitar 60–70% anak dengan epilepsi bisa mencapai kondisi bebas kejang hanya dengan satu obat lini pertama saja, tanpa perlu obat kombinasi.

Dokter jugalah yang harus menentukan kapan anak perlu dirujuk ke dokter saraf anak. Diagnosis dan pengobatan yang terlambat atau kurang tepat, dapat berdampak besar pada perkembangan anak dan kualitas hidup keluarganya.

Buku ini saya susun sebagai panduan praktis yang ringkas namun padat, untuk membantu sejawat dokter umum dan dokter anak dalam mengenali berbagai jenis bangkitan epilepsi, memahami klasifikasi berdasarkan kriteria International League Against Epilepsy (ILAE), serta mengambil keputusan klinis yang tepat dan aman.

Penjelasan dalam buku ini tidak bertele-tele, disajikan dengan bahasa sederhana, tabel ringkas, dan ilustrasi klinis agar mudah diterapkan dalam praktik sehari-hari, bahkan dalam waktu yang terbatas di layanan primer. Penulisan referensi sebagai sitasi dalam teks saya tiadakan dan hanya beberapa referensi yang saya tuliskan di akhir buku.

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Salam hangat,

Prof. Dr. dr. Hardiono D. Pusponegoro, Sp.A(K)

Konsultan Neurologi Anak, Guru Besar Ilmu Kesehatan Anak

Jakarta, September 2025

@anakkuid

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Bab 1: Apa itu Epilepsi?	1
Bab 2: Klasifikasi bangkitan epilepsi	5
Bab 3: Manifestasi klinis bangkitan epilepsi pada anak	9
Bab 4: Obat anti-epilepsi (OAE) di Indonesia	19
Bab 5: Prinsip terapi awal epilepsi	27
Bab 6: Pemilihan OAE berdasarkan jenis bangkitan	31
Bab 7: Cara memantau anak dengan epilepsi	35
Bab 8: Kapan harus merujuk ke spesialis saraf atau konsultan saraf anak	41
Bab 9: Pengenalan sindrom epilepsi spesifik pada anak dan bayi	45
Bab 10: Edukasi untuk keluarga dan sekolah	51
Bab 11: Lampiran praktis	57
Penutup: Pesan dan Harapan	62
Daftar Rujukan	64
Profil Penulis	67

Daftar Tabel

• Daftar obat lini pertama untuk anak (di Indonesia)	20
• Obat lini kedua (hanya diresepkan oleh dokter saraf atau konsultan saraf anak)	21
• Efek samping serius yang harus diwaspadai	22
• Kapan boleh mulai obat setelah kejang pertama?	29
• Pemilihan OAE berdasarkan jenis bangkitan	33
• Kapan tidak memberikan obat tertentu?	33
• Frekuensi dan pola kejang	36
• Pemantauan efek samping obat	37
• Sindrom epilepsi khusus yang perlu dirujuk	43
• Sindrom West	47
• Dravet Syndrome	47
• Lennox-Gastaut Syndrome	48
• Panayiotopoulos Syndrome	48
• CSWS/ESES (Continuous Spike-Wave Sleep/Electrical Status in Sleep)	49
• Edukasi anti stigma	55
• Anamnesis kejang pertama	58
• Buku catatan kejang harian	60